

Composition:

Each ESIUM (20-40) Capsule contains: Esomeprazole magnesium trihydrate equivalent to Esomeprazole (20-40) mg as Enteric Coated Pellets.

Mechanism of Action:

Esomeprazole is a weak base, it is concentrated in the highly acidic environment of the secretory canaliculi of the parietal cell and it converted into its active form where it inhibits the acid pump H^+/K^+ -ATPase enzyme and therefore inhibits both basal and stimulated acid secretion.

Pharmacokinetics:

Absorption: Absorption of esomeprazole is rapid, with peak plasma levels occurring approximately 1-2 hours after dose. The absolute bioavailability is 64% after a single dose of 40 mg and increases to 89% after repeated once-daily administration. For 20 mg esomeprazole the corresponding values are 50% and 68%, respectively.

Distribution: Esomeprazole is 97% bound to plasma proteins. The apparent volume of distribution at steady state is approximately 16 L.

Metabolism: Esomeprazole is completely metabolized in the liver by the cytochrome P450 system (CYP). A major part of esomeprazole's metabolism is dependent upon the CYP2C19 isoenzyme and remaining amount is dependent on CYP3A4.

Excretion: The plasma elimination half-life of esomeprazole is approximately 1 to 1.5 hours. Less than 1% of non-metabolized drug is excreted in the urine. Approximately 80% of an oral dose of esomeprazole is excreted as inactive metabolites in the urine, and the remainder is found as inactive metabolites in the feces.

Indications: ESIUM is a proton pump inhibitor indicated in the following cases:

- Treatment of gastroesophageal reflux disease (GERD).
- Risk reduction of NSAID-associated gastric ulcer.
- H. pylori treatment to reduce the risk of duodenal ulcer recurrence.
- Pathological hypersecretory conditions, including Zollinger-Elison syndrome.

Contraindications:

Esomeprazole is contraindicated in patients with hypersensitivity to any component of the product.

Warnings & Precautions:

- Malignancy should be excluded, when gastric ulcer is suspected, as treatment with Esomeprazole may alleviate symptoms and delay diagnosis.
- Hypomagnesemia has been reported in rare cases with prolonged use of proton pump inhibitors.
- Bone Fracture: Long-term and multiple daily dose PPI therapy may be associated with an increased risk for osteoporosis-related fractures of the hip, wrist or spine especially in the elderly.
- Acute interstitial nephritis has been observed in patients taking PPIs.
- Vitamin B12 deficiency: Long-term daily (e.g., longer than 3 years) use of proton pump inhibitors may lead to malabsorption, or a decrease in blood levels of cyanocobalamin.
- PPI therapy may be associated with increased risk of Clostridium difficile associated diarrhea.

Pregnancy & Lactation:

Pregnancy: Pregnancy category C. ESIUM should be used during pregnancy only if the potential benefit justifies the potential risk to the fetus.

Lactation: Because Esomeprazole is likely to be excreted in mother milk, caution should be exercised when ESIUM is administered to a nursing woman.

Drug Interactions:

- Antiretroviral drugs: Concomitant use of atazanavir with proton pump inhibitors may lead to a significant decrease in plasma concentrations of atazanavir, and concomitant use of saquinavir with proton pump inhibitors may lead to an increase in plasma concentrations

of saquinavir, which increases toxicity and requires dose reduction.

- Interference may occur with drugs whose bioavailability may be affected by gastric pH. Absorption of some drugs (e.g., ketconazole, iron salts, erlotinib, mycophenolate mofetil) is decreased, while the absorption of some drugs (e.g., digoxin) may be increased during treatment with esomeprazole. (Patients treated with ESIUM and digoxin may need to be monitored for digoxin toxicity).

- Concomitant administration of esomeprazole with clopidogrel may lead to a decrease in plasma concentrations of the active metabolite of clopidogrel.

- Methotrexate: ESIUM may increase serum levels of methotrexate.

- Drugs that induce CYP2C19, CYP3A4, or both (e.g., rifampin). Concomitant administration of esomeprazole may decrease esomeprazole serum levels.

- Drugs that inhibit CYP2C19, CYP3A4 enzymes (e.g., voriconazole): Co-administration of esomeprazole with these drugs may increase esomeprazole serum levels.

- Tacrolimus: ESIUM may increase serum levels of tacrolimus.

Side Effects:

Most common adverse reactions are headache, diarrhea, nausea, flatulence, abdominal pain, constipation, and dry mouth.

Driving & Using Machines:

Esomeprazole has a slight effect on the ability to drive and use machines.

Dosage & Administration:

Recommended dosage schedule of Esomeprazole is:

Indications		Dose	Frequency of administration
Adults and Adolescents from the age of 12 years	Gastroesophageal Reflux Disease (GERD)	20 mg or 40 mg	Once daily for 4 to 8 weeks
	Long-term management of patients with healed esophagitis to prevent relapse	20 mg	Once daily*
	Symptomatic GERD	20 mg	Once daily for 4 weeks
	Risk Reduction of NSAID associated gastric ulcer	20 mg or 40 mg	Once daily for up to 6 months
Zollinger-Elison syndrome		40 mg	Twice daily
H. pylori treatment (Triple therapy)			
Esomeprazole	20 mg		Twice daily for 10 days
Amoxicillin	1000 mg		Twice daily for 10 days
Clarithromycin	500 mg		Twice daily for 10 days

* Controlled studies did not extend beyond six months.

- Patients with severe liver impairment do not exceed dose of 20 mg.

Overdose:

There is very limited data to date regarding intentional overdose.

Symptoms:

The symptoms described in relation to taking a dose of 280 mg are general weakness, digestive symptoms. Single doses of esomeprazole 80 mg were asymptomatic.

Treatment:

There is no specific antidote. Esomeprazole is highly bound to plasma proteins and therefore cannot be easily eliminated by hemodialysis. As in any case of overdose, treatment should be tailored to the symptoms and general supportive measures should be used.

Storage:

Keep out of reach of children. Store below 25°C.

Packaging:

Each ESIUM (20 - 40) carton box contains 20 capsules in two blister strips.

*A medication is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- The doctor and the pharmacist's experts in medicine, it's benefits and risks.
KEEP THE MEDICATIONS OUT OF REACH OF CHILDREN
Council of Arab Health Ministries - Union of Arab Pharmacists



إيزيوم كبسول

التركيب:

كل كبسولة إيزيوم (٢٠-٤٠) تحتوي على: إيزوميبرازول ثلاثي هيدرات المغنيزيوم مايعادل إيزوميبرازول (٢٠-٤٠) ملغ على شكل حبيبات ملبسة معويًا.

آلية التأثير:

إيزوميبرازول هو أساس ضعيف، يتركز في البيئة شديدة الحموضة للفتوات الإفرازية للخلية الجدارية ويتحول فيها إلى شكله الفعال، حيث يتبط بشكل انتقائي إنزيم مضخة الحمض $H^+/K^+ - ATPase$ وبالتالي يتبط إفراز كل من الحمض القاعدي والحفزر.

الحرائك الدوائية:

الامتصاص: يتم امتصاص الإيزوميبرازول بشكل سريع، ويصل إلى ذروة مستويات البلازمية بعد ٢-١ ساعة تقريباً من تناول الجرعة. التوافر الحيوي المطلق ٦٤٪ بعد تناول جرعة واحدة ٤٠ ملغ ويزيد إلى ٨٩٪ بعد إعطاءه المتكرر مرة واحدة يومياً. بالنسبة لجرعة ٢٠ ملغ من إيزوميبرازول، تكون القيم المقابلة ٥٠٪ و٦٨٪ على التوالي. التوزيع: يرتبط إيزوميبرازول بنسبة ٩٧٪ بروتينات البلازما. الحجم الظاهر للتوزع في الحالة المستقرة حوالي ١٦ لتر.

الاستقلاب: يتم استقلاب إيزوميبرازول بالكامل في الكبد عن طريق مجموعة إنزيمات السيوكروم P450 (CYP)، يعتمد الجزء الأكبر من استقلاب الإيزوميبرازول على إنزيم CYP2C19 والكمية المتبقية تُستقلب عن طريق CYP3A4.

الإخراج: يبلغ العمر النصفى لإخراج الإيزوميبرازول من البلازما حوالي ١,٥ ساعة. يطرح أقل من ١٪ من الدواء غير المستقلب في البول. يُطرح ما يقارب ٨٠٪ من جرعة من إيزوميبرازول الفموية على شكل مستقلبات غير فعالة في البول، وما تبقى من المستقلبات غير الفعالة تطرح في البراز. الاستطبابات: إيزيوم هو مثبط لمضخة البروتون بوصف في الحالات التالية:

- علاج مرض القرحة الهضمية المعدي.
- الحد من مخاطر القرحة المعدية المرتبطة بتناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.
- علاج الملوية البوابية للحد من خطر تكرار قرحة الإثني عشر.
- حالات قرط الإفراز المرضي، بما في ذلك متلازمة زولينجر اليسون.

مضادات الاستطباب:

إيزوميبرازول هو مضاد استطباب لدى المرضى الذين لديهم حساسية مفرطة تجاه أي مكون من مكونات المستحضر.

التحذيرات والاحتياطات:

- يجب استبعاد احتمالية الإصابة بالورم الخبيث عند الاشتباه بوجود قرحة في المعدة، لأن العلاج بإيزوميبرازول قد يخفف الأعراض ويؤخر التشخيص.
- تم الإبلاغ عن حدوث نقص في مغنيزيوم الدم في حالات نادرة عند استعمال مضطبات مضخة البروتون لفترة طويلة.
- الكسور العظمية: قد يترافق العلاج بمضطبات مضخة البروتون على المدى الطويل والمتعدد بزيادة خطر الإصابة بكسور الورك أو الرضع أو العمود الفقري المرتبطة بنشاشة العظام خاصة لدى كبار السن.
- لوحظت حالات من التهاب الكلىة الخلالي الحاد عند المرضى الذين يتناولون مضطبات مضخة البروتون.
- نقص فيتامين ب١٢: الاستخدام اليومي طويل الأمد (مثلاً لمدة أطول من ٣ سنوات) لمضطبات مضخة البروتون قد يؤدي إلى سوء امتصاص، أو نقص في مستويات السيانتوكوبالامين في الدم.
- قد يترافق العلاج بمضطبات مضخة البروتون مع زيادة خطر الإصابة بالإسهال المصاحب للمثوية المسرة.

الحمل والرضاع:

الحمل: التصنيف الحلمي C، يجب استخدام إيزيوم أثناء الحمل فقط إذا كانت الفائدة المرجوة تبرز المخاطر المحتملة على الجنين.

الرضاع: بسبب احتمال إفراز إيزوميبرازول في حليب الثدي، يجب توخي الحذر عند إعطاء إيزيوم للمرأة المرضع.

التفاعلات الدوائية:

- الأدوية المضادة للفروقات القهقرية: الاستخدام المتزامن لأتازانافير مع مضطبات مضخة البروتون قد يؤدي إلى انخفاض كبير في تراكيز أتازانافير البلازمية، كما أن الاستخدام المتزامن لاسكواينافير مع مضطبات مضخة البروتون قد يؤدي إلى زيادة تراكيز سالكواينافير البلازمية مما يزيد السمية ويتطلب تخفيض الجرعة.

- قد يحدث تداخل مع الأدوية التي يمكن أن تؤثر درجة الحموضة في المعدة على التوافر الحيوي لها. ينخفض امتصاص بعض الأدوية (مثل الكيتوكونازول وأملاح الحديد والإيزونيتيب والميكوفينولات موفيتيل)، بينما يمكن أن يزداد امتصاص بعض الأدوية (مثل الديجوكسين) أثناء العلاج باستخدام إيزوميبرازول. قد يحدث انخفاض التئين عولجوا باستخدام إيزيوم والديجوكسين إلى المراقبة لتقسيمي عن سموية الديجوكسين).

- قد يؤدي الاستخدام المتزامن لإيزوميبرازول مع الكلوبيدوغريل إلى انخفاض تراكيز المستقلب الفعال للكلوبيدوغريل في البلازما. الميونيتركتات: قد يزيد إيزيوم من مستويات الميونيتركتات في المصل.

- الأدوية المحفزة لإنزيمات السيوكروم CYP2C19 أو CYP3A4 أو كليهما (على سبيل المثال، ريفامبين) قد يؤدي تناول إيزوميبرازول مع هذه الأدوية إلى انخفاض مستويات الإيزوميبرازول المصلية.

- الأدوية المثبطة لأنزيمات السيوكروم CYP2C19 أو CYP3A4 (على سبيل المثال، فريكونازول): قد يؤدي تناول إيزوميبرازول مع هذه الأدوية إلى زيادة مستويات الإيزوميبرازول المصلية.

- تاكلوليومون: قد يزيد إيزيوم من مستويات التاكلوليومون المصلية.

التأثيرات الجانبية:

أكثر التأثيرات الجانبية شيوعاً هي: الصداع، والإسهال، الغثيان، انتفاخ والأم البطن، الإمساك وجفاف الفم.

الوقاية واستخدام الآلات: يمكن للإيزوميبرازول تأثيراً طفيفاً على القدرة على القيادة واستخدام الآلات.

الجرعة والاستعمال:

جدول الجرعة الموصى بها من إيزوميبرازول كالتالي:

الاستطباب	الجرعة	تواتر الإعطاء
معالجة داء الفطن المعدي المريئي	٢٠، ٤٠ ملغ	مرة واحدة يومياً لمدة ٨ أسابيع
التئير العلاججي طويل الأمد لمرضى التهاب المريء التآكلي لمنع الانتكاس	٢٠ ملغ	مرة واحدة يومياً *
المعالجة المرضية الداء الفطن المعدي المريئي	٢٠، ٤٠ ملغ	مرة واحدة يومياً لمدة ٤ أسابيع
تقليل خطورة الإصابة بالقرحة المعوية المراقبة	٢٠، ٤٠ ملغ	مرة واحدة يومياً لمدة ٤ أسابيع
استعمال مضطبات التهاب غير الستيرويدية	٤٠، ٦٠ ملغ	مرة واحدة يومياً لمدة ٦ أشهر
متلازمة زولينجر اليسون	٤٠ ملغ	مرتين باليوم
علاج جرثومة المتلوية البوابية (علاج ثلاثي)		
إيزوميبرازول	٢٠ ملغ	مرتين يومياً لمدة ١٠ أيام
أموكسيسيلين	١٠٠٠ ملغ	مرتين يومياً لمدة ١٠ أيام
كلاريثروميسين	٥٠٠ ملغ	مرتين يومياً لمدة ١٠ أيام

* لم تتجاوز الدراسات الخاضعة للمراقبة فترة أكثر من ٦ أشهر.

في مرضى القصور الكلوي الحاد يجب ألا تتجاوز الجرعة ٢٠ ملغ.

فرط الجرعة:

هناك بيانات محدودة جداً الآن فيما يتعلق بتناول جرعة زائدة متعمدة.

الأعراض:

الأعراض الموصوفة فيما يتعلق بتناول جرعة ٢٨٠ ملغ هي ضعف عام، أعراض هضمية. كانت الجرعات المفردة من إيزوميبرازول ٨٠ ملغ غير مسببة للأعراض.

العلاج:

لا يوجد ترياق محدد. يرتبط إيزوميبرازول بشكل كبير ببروتينات البلازما وبالتالي لا يمكن التخلص منه عن طريق غسيل الكلى بسهولة. كما هو الحال في أي حالة من حالات الجرعة الزائدة، يجب أن يكون العلاج مخصصاً للأعراض ويجب استخدام التدابير الداعمة العامة.

الحفظ:

يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. يُحفظ في درجة حرارة أقل من ٢٥°م.

التعبئة:

كل عبوة كرتونية إيزيوم (٢٠ - ٤٠) تحتوي على ٢٠ كبسولة ضمن شريطين بليستر.

دواء مستحضر بوتر في حبة، وإضافة خلاصة الفيتامينات مع ذلك الحبة (فيتامينات ب١، ب٢، ب٦، ب١٢، ب١٥، ب١٦، ب١٧، ب١٩، ب٢٠، ب٢١، ب٢٢، ب٢٣، ب٢٤، ب٢٥، ب٢٦، ب٢٧، ب٢٨، ب٢٩، ب٣٠، ب٣١، ب٣٢، ب٣٣، ب٣٤، ب٣٥، ب٣٦، ب٣٧، ب٣٨، ب٣٩، ب٤٠، ب٤١، ب٤٢، ب٤٣، ب٤٤، ب٤٥، ب٤٦، ب٤٧، ب٤٨، ب٤٩، ب٥٠، ب٥١، ب٥٢، ب٥٣، ب٥٤، ب٥٥، ب٥٦، ب٥٧، ب٥٨، ب٥٩، ب٦٠، ب٦١، ب٦٢، ب٦٣، ب٦٤، ب٦٥، ب٦٦، ب٦٧، ب٦٨، ب٦٩، ب٧٠، ب٧١، ب٧٢، ب٧٣، ب٧٤، ب٧٥، ب٧٦، ب٧٧، ب٧٨، ب٧٩، ب٨٠، ب٨١، ب٨٢، ب٨٣، ب٨٤، ب٨٥، ب٨٦، ب٨٧، ب٨٨، ب٨٩، ب٩٠، ب٩١، ب٩٢، ب٩٣، ب٩٤، ب٩٥، ب٩٦، ب٩٧، ب٩٨، ب٩٩، ب١٠٠، ب١٠١، ب١٠٢، ب١٠٣، ب١٠٤، ب١٠٥، ب١٠٦، ب١٠٧، ب١٠٨، ب١٠٩، ب١١٠، ب١١١، ب١١٢، ب١١٣، ب١١٤، ب١١٥، ب١١٦، ب١١٧، ب١١٨، ب١١٩، ب١٢٠، ب١٢١، ب١٢٢، ب١٢٣، ب١٢٤، ب١٢٥، ب١٢٦، ب١٢٧، ب١٢٨، ب١٢٩، ب١٣٠، ب١٣١، ب١٣٢، ب١٣٣، ب١٣٤، ب١٣٥، ب١٣٦، ب١٣٧، ب١٣٨، ب١٣٩، ب١٤٠، ب١٤١، ب١٤٢، ب١٤٣، ب١٤٤، ب١٤٥، ب١٤٦، ب١٤٧، ب١٤٨، ب١٤٩، ب١٥٠، ب١٥١، ب١٥٢، ب١٥٣، ب١٥٤، ب١٥٥، ب١٥٦، ب١٥٧، ب١٥٨، ب١٥٩، ب١٦٠، ب١٦١، ب١٦٢، ب١٦٣، ب١٦٤، ب١٦٥، ب١٦٦، ب١٦٧، ب١٦٨، ب١٦٩، ب١٧٠، ب١٧١، ب١٧٢، ب١٧٣، ب١٧٤، ب١٧٥، ب١٧٦، ب١٧٧، ب١٧٨، ب١٧٩، ب١٨٠، ب١٨١، ب١٨٢، ب١٨٣، ب١٨٤، ب١٨٥، ب١٨٦، ب١٨٧، ب١٨٨، ب١٨٩، ب١٩٠، ب١٩١، ب١٩٢، ب١٩٣، ب١٩٤، ب١٩٥، ب١٩٦، ب١٩٧، ب١٩٨، ب١٩٩، ب٢٠٠، ب٢٠١، ب٢٠٢، ب٢٠٣، ب٢٠٤، ب٢٠٥، ب٢٠٦، ب٢٠٧، ب٢٠٨، ب٢٠٩، ب٢١٠، ب٢١١، ب٢١٢، ب٢١٣، ب٢١٤، ب٢١٥، ب٢١٦، ب٢١٧، ب٢١٨، ب٢١٩، ب٢٢٠، ب٢٢١، ب٢٢٢، ب٢٢٣، ب٢٢٤، ب٢٢٥، ب٢٢٦، ب٢٢٧، ب٢٢٨، ب٢٢٩، ب٢٣٠، ب٢٣١، ب٢٣٢، ب٢٣٣، ب٢٣٤، ب٢٣٥، ب٢٣٦، ب٢٣٧، ب٢٣٨، ب٢٣٩، ب٢٤٠، ب٢٤١، ب٢٤٢، ب٢٤٣، ب٢٤٤، ب٢٤٥، ب٢٤٦، ب٢٤٧، ب٢٤٨، ب٢٤٩، ب٢٥٠، ب٢٥١، ب٢٥٢، ب٢٥٣، ب٢٥٤، ب٢٥٥، ب٢٥٦، ب٢٥٧، ب٢٥٨، ب٢٥٩، ب٢٦٠، ب٢٦١، ب٢٦٢، ب٢٦٣، ب٢٦٤، ب٢٦٥، ب٢٦٦، ب٢٦٧، ب٢٦٨، ب٢٦٩، ب٢٧٠، ب٢٧١، ب٢٧٢، ب٢٧٣، ب٢٧٤، ب٢٧٥، ب٢٧٦، ب٢٧٧، ب٢٧٨، ب٢٧٩، ب٢٨٠، ب٢٨١، ب٢٨٢، ب٢٨٣، ب٢٨٤، ب٢٨٥، ب٢٨٦، ب٢٨٧، ب٢٨٨، ب٢٨٩، ب٢٩٠، ب٢٩١، ب٢٩٢، ب٢٩٣، ب٢٩٤، ب٢٩٥، ب٢٩٦، ب٢٩٧، ب٢٩٨، ب٢٩٩، ب٣٠٠، ب٣٠١، ب٣٠٢، ب٣٠٣، ب٣٠٤، ب٣٠٥، ب٣٠٦، ب٣٠٧، ب٣٠٨، ب٣٠٩، ب٣١٠، ب٣١١، ب٣١٢، ب٣١٣، ب٣١٤، ب٣١٥، ب٣١٦، ب٣١٧، ب٣١٨، ب٣١٩، ب٣٢٠، ب٣٢١، ب٣٢٢، ب٣٢٣، ب٣٢٤، ب٣٢٥، ب٣٢٦، ب٣٢٧، ب٣٢٨، ب٣٢٩، ب٣٣٠، ب٣٣١، ب٣٣٢، ب٣٣٣، ب٣٣٤، ب٣٣٥، ب٣٣٦، ب٣٣٧، ب٣٣٨، ب٣٣٩، ب٣٤٠، ب٣٤١، ب٣٤٢، ب٣٤٣، ب٣٤٤، ب٣٤٥، ب٣٤٦، ب٣٤٧، ب٣٤٨، ب٣٤٩، ب٣٥٠، ب٣٥١، ب٣٥٢، ب٣٥٣، ب٣٥٤، ب٣٥٥، ب٣٥٦، ب٣٥٧، ب٣٥٨، ب٣٥٩، ب٣٦٠، ب٣٦١، ب٣٦٢، ب٣٦٣، ب٣٦٤، ب٣٦٥، ب٣٦٦، ب٣٦٧، ب٣٦٨، ب٣٦٩، ب٣٧٠، ب٣٧١، ب٣٧٢، ب٣٧٣، ب٣٧٤، ب٣٧٥، ب٣٧٦، ب٣٧٧، ب٣٧٨، ب٣٧٩، ب٣٨٠، ب٣٨١، ب٣٨٢، ب٣٨٣، ب٣٨٤، ب٣٨٥، ب٣٨٦، ب٣٨٧، ب٣٨٨، ب٣٨٩، ب٣٩٠، ب٣٩١، ب٣٩٢، ب٣٩٣، ب٣٩٤، ب٣٩٥، ب٣٩٦، ب٣٩٧، ب٣٩٨، ب٣٩٩، ب٤٠٠، ب٤٠١، ب٤٠٢، ب٤٠٣، ب٤٠٤، ب٤٠٥، ب٤٠٦، ب٤٠٧، ب٤٠٨، ب٤٠٩، ب٤١٠، ب٤١١، ب٤١٢، ب٤١٣، ب٤١٤، ب٤١٥، ب٤١٦، ب٤١٧، ب٤١٨، ب٤١٩، ب٤٢٠، ب٤٢١، ب٤٢٢، ب٤٢٣، ب٤٢٤، ب٤٢٥، ب٤٢٦، ب٤٢٧، ب٤٢٨، ب٤٢٩، ب٤٣٠، ب٤٣١، ب٤٣٢، ب٤٣٣، ب٤٣٤، ب٤٣٥، ب٤٣٦، ب٤٣٧، ب٤٣٨، ب٤٣٩، ب٤٤٠، ب٤٤١، ب٤٤٢، ب٤٤٣، ب٤٤٤، ب٤٤٥، ب٤٤٦، ب٤٤٧، ب٤٤٨، ب٤٤٩، ب٤٥٠، ب٤٥١، ب٤٥٢، ب٤٥٣، ب٤٥٤، ب٤٥٥، ب٤٥٦، ب٤٥٧، ب٤٥٨، ب٤٥٩، ب٤٦٠، ب٤٦١، ب٤٦٢، ب٤٦٣، ب٤٦٤، ب٤٦٥، ب٤٦٦، ب٤٦٧، ب٤٦٨، ب٤٦٩، ب٤٧٠، ب٤٧١، ب٤٧٢، ب٤٧٣، ب٤٧٤، ب٤٧٥، ب٤٧٦، ب٤٧٧، ب٤٧٨، ب٤٧٩، ب٤٨٠، ب٤٨١، ب٤٨٢، ب٤٨٣، ب٤٨٤، ب٤٨٥، ب٤٨٦، ب٤٨٧، ب٤٨٨، ب٤٨٩، ب٤٩٠، ب٤٩١، ب٤٩٢، ب٤٩٣، ب٤٩٤، ب٤٩٥، ب٤٩٦، ب٤٩٧، ب٤٩٨، ب٤٩٩، ب٥٠٠، ب٥٠١، ب٥٠٢، ب٥٠٣، ب٥٠٤، ب٥٠٥، ب٥٠٦، ب٥٠٧، ب٥٠٨، ب٥٠٩، ب٥١٠، ب٥١١، ب٥١٢، ب٥١٣، ب٥١٤، ب٥١٥، ب٥١٦، ب٥١٧، ب٥١٨، ب٥١٩، ب٥٢٠، ب٥٢١، ب٥٢٢، ب٥٢٣، ب٥٢٤، ب٥٢٥، ب٥٢٦، ب٥٢٧، ب٥٢٨، ب٥٢٩، ب٥٣٠، ب٥٣١، ب٥٣٢، ب٥٣٣، ب٥٣٤، ب٥٣٥، ب٥٣٦، ب٥٣٧، ب٥٣٨، ب٥٣٩، ب٥٤٠، ب٥٤١، ب٥٤٢، ب٥٤٣، ب٥٤٤، ب٥٤٥، ب٥٤٦، ب٥٤٧، ب٥٤٨، ب٥٤٩، ب٥٥٠، ب٥٥١، ب٥٥٢، ب٥٥٣، ب٥٥٤، ب٥٥٥، ب٥٥٦، ب٥٥٧، ب٥٥٨، ب٥٥٩، ب٥٦٠، ب٥٦١، ب٥٦٢، ب٥٦٣، ب٥٦٤، ب٥٦٥، ب٥٦٦، ب٥٦٧، ب٥٦٨، ب٥٦٩، ب٥٧٠، ب٥٧١، ب٥٧٢، ب٥٧٣، ب٥٧٤، ب٥٧٥، ب٥٧٦، ب٥٧٧، ب٥٧٨، ب٥٧٩، ب٥٨٠، ب٥٨١، ب٥٨٢، ب٥٨٣، ب٥٨٤، ب٥٨٥، ب٥٨٦، ب٥٨٧، ب٥٨٨، ب٥٨٩، ب٥٩٠، ب٥٩١، ب٥٩٢، ب٥٩٣، ب٥٩٤، ب٥٩٥، ب٥٩٦، ب٥٩٧، ب٥٩٨، ب٥٩٩، ب٦٠٠، ب٦٠١، ب٦٠٢، ب٦٠٣، ب٦٠٤، ب٦٠٥، ب٦٠٦، ب٦٠٧، ب٦٠٨، ب٦٠٩، ب٦١٠، ب٦١١، ب٦١٢، ب٦١٣، ب٦١٤، ب٦١٥، ب٦١٦، ب٦١٧، ب٦١٨، ب٦١٩، ب٦٢٠، ب٦٢١، ب٦٢٢، ب٦٢٣، ب٦٢٤، ب٦٢٥، ب٦٢٦، ب٦٢٧، ب٦٢٨، ب٦٢٩، ب٦٣٠، ب٦٣١، ب٦٣٢، ب٦٣٣، ب٦٣٤، ب٦٣٥، ب٦٣٦، ب٦٣٧، ب٦٣٨، ب٦٣٩، ب٦٤٠، ب٦٤١، ب٦٤٢، ب٦٤٣، ب٦٤٤، ب٦٤٥، ب٦٤٦، ب٦٤٧، ب٦٤٨، ب٦٤٩، ب٦٥٠، ب٦٥١، ب٦٥٢، ب٦٥٣، ب٦٥٤، ب٦٥٥، ب٦٥٦، ب٦٥٧، ب٦٥٨، ب٦٥٩، ب٦٦٠، ب٦٦١، ب٦٦٢، ب٦٦٣، ب٦٦٤، ب٦٦٥، ب٦٦٦، ب٦٦٧، ب٦٦٨، ب٦٦٩، ب٦٧٠، ب٦٧١، ب٦٧٢، ب٦٧٣، ب٦٧٤، ب٦٧٥، ب٦٧٦، ب٦٧٧، ب٦٧٨، ب٦٧٩، ب٦٨٠، ب٦٨١، ب٦٨٢، ب٦٨٣، ب٦٨٤، ب٦٨٥، ب٦٨٦، ب٦٨٧، ب٦٨٨، ب٦٨٩، ب٦٩٠، ب٦٩١، ب٦٩٢، ب٦٩٣، ب٦٩٤، ب٦٩٥، ب٦٩٦، ب٦٩٧، ب٦٩٨، ب٦٩٩، ب٧٠٠، ب٧٠١، ب٧٠٢، ب٧٠٣، ب٧٠٤، ب٧٠٥، ب٧٠٦، ب٧٠٧، ب٧٠٨، ب٧٠٩، ب٧١٠، ب٧١١، ب٧١٢، ب٧١٣، ب٧١٤، ب٧١٥، ب٧١٦، ب٧١٧، ب٧١٨، ب٧١٩، ب٧٢٠، ب٧٢١، ب٧٢٢، ب٧٢٣، ب٧٢٤، ب٧٢٥، ب٧٢٦، ب٧٢٧، ب٧٢٨، ب٧٢٩، ب٧٣٠، ب٧٣١، ب٧٣٢، ب٧٣٣، ب٧٣٤، ب٧٣٥، ب٧٣٦، ب٧٣٧، ب٧٣٨، ب٧٣٩، ب٧٤٠، ب٧٤١، ب٧٤٢، ب٧٤٣، ب٧٤٤، ب٧٤٥، ب٧٤٦، ب٧٤٧، ب٧٤٨، ب٧٤٩، ب٧٥٠، ب٧٥١، ب٧٥٢، ب٧٥٣، ب٧٥٤، ب٧٥٥، ب٧٥٦، ب٧٥٧، ب٧٥٨، ب٧٥٩، ب٧٦٠، ب٧٦١، ب٧٦٢، ب٧٦٣، ب٧٦٤، ب٧٦٥، ب٧٦٦، ب٧٦٧، ب٧٦٨، ب٧٦٩، ب٧٧٠، ب٧٧١، ب٧٧٢، ب٧٧٣، ب٧٧٤، ب٧٧٥، ب٧٧٦، ب٧٧٧، ب٧٧٨، ب٧٧٩، ب٧٨٠، ب٧٨١، ب٧٨٢، ب٧٨٣، ب٧٨٤، ب٧٨٥، ب٧٨٦، ب٧٨٧، ب٧٨٨، ب٧٨٩، ب٧٩٠، ب٧٩١، ب٧٩٢، ب٧٩٣، ب٧٩٤، ب٧٩٥، ب٧٩٦، ب٧٩٧، ب٧٩٨، ب٧٩٩، ب٨٠٠، ب٨٠١، ب٨٠٢، ب٨٠٣، ب٨٠٤، ب٨٠٥، ب٨٠٦، ب٨٠٧، ب٨٠٨، ب٨٠٩، ب٨١٠، ب٨١١، ب٨١٢، ب٨١٣، ب٨١٤، ب٨١٥، ب٨١٦، ب٨١٧، ب٨١٨، ب٨١٩، ب٨٢٠، ب٨٢١، ب٨٢٢، ب٨٢٣، ب٨٢٤، ب٨٢٥، ب٨٢٦، ب٨٢٧، ب٨٢٨، ب٨٢٩، ب٨٣٠، ب٨٣١، ب٨٣٢، ب٨٣٣، ب٨٣٤، ب٨٣٥، ب٨٣٦، ب٨٣٧، ب٨٣٨، ب٨٣٩، ب٨٤٠، ب٨٤١، ب٨٤٢، ب٨٤٣، ب٨٤٤، ب٨٤٥، ب٨٤٦، ب٨٤٧، ب٨٤٨، ب٨٤٩، ب٨٥٠، ب٨٥١، ب٨٥٢، ب٨٥٣، ب٨٥٤، ب٨٥٥، ب٨٥٦، ب٨٥٧، ب٨٥٨، ب٨٥٩، ب٨٦٠، ب٨٦١، ب٨٦٢، ب٨٦٣، ب٨٦٤، ب٨٦٥، ب٨٦٦، ب٨٦٧، ب٨٦٨، ب٨٦٩، ب٨٧٠، ب٨٧١، ب٨٧٢، ب٨٧٣، ب٨٧٤، ب٨٧٥، ب٨٧٦، ب٨٧٧، ب٨٧٨، ب٨٧٩، ب٨٨٠، ب٨٨١، ب٨٨٢، ب٨٨٣، ب٨٨٤، ب٨٨٥، ب٨٨٦، ب٨٨٧، ب٨٨٨، ب٨٨٩، ب٨٩٠، ب٨٩١، ب٨٩٢، ب٨٩٣، ب٨٩٤، ب٨٩٥، ب٨٩٦، ب٨٩٧، ب٨٩٨، ب٨٩٩، ب٩٠٠، ب٩٠١، ب٩٠٢، ب٩٠٣، ب٩٠٤، ب٩٠٥، ب٩٠٦، ب٩٠٧، ب٩٠٨، ب٩٠٩، ب٩١٠، ب٩١١، ب٩١٢، ب٩١٣، ب٩١٤، ب٩١٥، ب٩١٦، ب٩١٧، ب٩١٨، ب٩١٩، ب٩٢٠، ب٩٢١، ب٩٢٢، ب٩٢٣، ب٩٢٤، ب٩٢٥، ب٩٢٦، ب٩٢٧، ب٩٢٨، ب٩٢٩، ب٩٣٠، ب٩٣١، ب٩٣٢، ب٩٣٣، ب٩٣٤، ب٩٣٥، ب٩٣٦، ب٩٣٧، ب٩٣٨، ب٩٣٩، ب٩٤٠، ب٩٤١، ب٩٤٢، ب٩٤٣، ب٩٤٤، ب٩٤٥، ب٩٤٦، ب٩٤٧، ب٩٤٨، ب٩٤٩، ب٩٥٠، ب٩٥١، ب٩٥٢، ب٩٥٣، ب٩٥٤، ب٩٥٥، ب٩٥٦، ب٩٥٧، ب٩٥٨، ب٩٥٩، ب٩٦٠، ب٩٦١، ب٩٦٢، ب٩٦٣، ب٩٦٤، ب٩٦٥، ب٩٦٦، ب٩٦٧، ب٩٦٨، ب٩٦٩، ب٩٧٠، ب٩٧١، ب٩٧٢، ب٩٧٣، ب٩٧٤، ب٩٧٥، ب٩٧٦، ب٩٧٧، ب٩٧٨، ب٩٧٩، ب٩٨٠، ب٩٨١، ب٩٨٢، ب٩٨٣، ب٩٨٤، ب٩٨٥، ب٩٨٦، ب٩٨٧، ب٩٨٨، ب٩٨٩، ب٩٩٠، ب٩٩١، ب٩٩٢، ب٩٩٣، ب٩٩٤، ب٩٩٥، ب٩٩٦، ب٩٩٧، ب٩٩٨، ب٩٩٩، ب١٠٠٠، ب١٠٠١، ب١٠٠٢، ب١٠٠٣، ب١٠٠٤، ب١٠٠٥، ب١٠٠٦، ب١٠٠٧، ب١٠٠٨، ب١٠٠٩، ب١٠١٠، ب١٠١١، ب١٠١٢، ب١٠١٣، ب١٠١٤، ب١٠١٥، ب١٠١٦، ب١٠١٧، ب١٠١٨، ب١٠١٩، ب١٠٢٠، ب١٠٢١، ب١٠٢٢، ب١٠٢٣، ب١٠٢٤، ب١٠٢٥، ب١٠٢٦، ب١٠٢٧، ب١٠٢٨، ب١٠٢٩، ب١٠٣٠، ب١٠٣١، ب١٠٣٢، ب١٠٣٣، ب١٠٣٤، ب١٠٣٥، ب١٠٣٦، ب١٠٣٧، ب١٠٣٨، ب١٠٣٩، ب١٠٤٠، ب١٠٤١، ب١٠٤٢، ب١٠٤٣، ب١٠٤٤، ب١٠٤٥، ب١٠٤٦، ب١٠٤٧، ب١٠٤٨، ب١٠٤٩، ب١٠٥٠، ب١٠٥١، ب١٠٥٢، ب١٠٥٣، ب١٠٥٤، ب١٠٥٥، ب١٠٥٦، ب١٠٥٧، ب١٠٥٨، ب١٠٥٩، ب١٠٦٠، ب